

TÉCNICA QUIRÚRGICA

MOTO® MEDIAL

SISTEMA DE RODILLA PARCIAL

REEMPLAZO UNICOMPARTIMENTAL MEDIAL

PRECAUCIÓN

- Algunas piezas se fijan al hueso utilizando unos pines específicos. Antes de utilizar los pines compruebe si están intactos y si son plenamente funcionales. **SI LOS PINES ESTÁN DOBLADOS O DEFECTUOSOS NO LOS UTILICE, SUSTITÚYALOS POR OTROS NUEVOS.** Es preciso extraer los pines para que no se doblen. Así se consigue una alineación axial entre el pin y el extractor específico.
- Se recomienda encarecidamente no golpear ni dar martillazos a ningún instrumento, a no ser que se especifique lo contrario en la técnica quirúrgica.

Para recibir instrucciones detalladas, póngase en contacto con su representante de ventas local.

Medacta International

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Medacta International

1 INTRODUCCIÓN 4
- 1.1 Indicaciones 4
- 1.2 Contraindicaciones 4
- 1.3 Filosofía de la técnica 4

2 PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA 5
- 2.1 Planificación radiológica 5
- 2.2 Planificación clínica 5
- 2.3 Plantilla de radiografía preoperatoria 5

3 ABORDAJE QUIRÚRGICO 6
- 3.1 Posicionamiento de las extremidades 6
- 3.2 Incisión y exposición 6
- 3.3 Resección de osteofitos 6

4 RESECCIÓN TIBIAL 7
- 4.1 Montaje y colocación de la guía de alineación extramedular 7
- 4.2 Ajuste del nivel de resección transversal de la tibia 8
- 4.3 Resección sagital 9
- 4.4 Resección tibial transversal 10
- 4.5 Evaluación del espacio en flexión y extensión 10
- 4.6 Ajuste del corte tibial 11

5 RESECCIÓN FEMORAL 12
- 5.1 Comprobación de la alineación en extensión 12
- 5.2 Resección distal 12
- 5.3 Control del espacio en extensión 14
- 5.4 Precorte del cóndilo femoral posterior 15
- 5.5 Dimensionamiento del fémur y corte posterior y chaflán 15

6 ACABADO TIBIAL 19
- 6.1 Dimensionamiento de la tibia y preparación de la quilla 19
- 6.2 Preparación de los pivotes tibiales 20

7 ENSAYO 22

8 ACABADO FEMORAL 24

9 COMPONENTES DEL IMPLANTE DEFINITIVO 25
- 9.1 Componente tibial 25
- 9.2 Componente femoral 26
- 9.3 Componente de inserto 26

10 RESUMEN DE LAS FASES 28

11 SELECCIÓN DE LOS COMPONENTES PROTÉSICOS — ADAPTACIÓN DEL TAMAÑO 30

12 NOMENCLATURA DE LOS IMPLANTES 31

13 NOMENCLATURA DE LA INSTRUMENTACIÓN 34

1. INTRODUCCIÓN

Este folleto describe la técnica quirúrgica del sistema parcial de rodilla MOTO® para un reemplazo unicompartimental medial.

MOTO® Medial se ha diseñado para sustituir el compartimento medial de la rodilla. El sistema contiene tanto implantes como instrumental diseñados para que el cirujano pueda realizar una reconstrucción unicondilar de la rodilla segura y reproducible, y evaluar el equilibrio de los tejidos blandos de la rodilla en cada fase. MOTO® Medial consta de componentes de fémur, base tibial e inserto tibial.

1.1 INDICACIONES

El Sistema de rodilla parcial MOTO® está diseñado para un uso cementado en artroplastia parcial de rodilla, si hay pruebas de un hueso sano suficiente para asentar y soportar los componentes. La sustitución parcial de las superficies articulares de la rodilla está indicada cuando solo está afectado un lado de la articulación debido a la enfermedad degenerativa primaria compartimental o postraumática, a las fracturas previas del cóndilo tibial o de la meseta, a la deformidad o a la revisión de una artroplastia anterior.

1.2 CONTRAINDICACIONES

El reemplazo parcial de rodilla está contraindicado en los casos siguientes:

- Infección progresiva local o sistémica.
- Pérdida muscular, enfermedad neuromuscular o deficiencia vascular de la extremidad afectada que haga injustificable la operación.
- Osteoporosis y osteomalacia.
- Trastornos metabólicos que pueden perjudicar la formación de los huesos.
- Destrucción rápida de la articulación, pérdida ósea o reabsorción ósea aparente en la roentgenografía.
- Tejidos blandos incompletos o deficientes que rodean la rodilla.
- Inestabilidad severa derivada de la destrucción avanzada de las estructuras condilares.
- La artroplastia unicompartimental de rodilla está contraindicada en pacientes que tienen una deformidad permanente en valgo o en varo que requiere corrección para que la rodilla funcione satisfactoriamente en el postoperatorio.

Los trastornos mentales o neuromusculares pueden crear un riesgo inaceptable para el paciente y pueden ser una fuente de complicaciones postoperatorias. El cirujano deberá comprobar que el paciente no tiene ninguna alergia conocida a los materiales utilizados.

1.3 FILOSOFÍA DE LA TÉCNICA

La artroplastia unicompartimental de rodilla (UKA) básicamente es una cirugía de tejidos blandos, y las resecciones de un milímetro de hueso realmente marcan la diferencia. La técnica MOTO® Medial se basa en puntos clave de control intraoperatorio y en opciones concretas de resección ósea con el objetivo de lograr el equilibrio de los tejidos blandos y la estabilidad de la rodilla en todo el rango de movimiento.

El objetivo es conseguir una ligera subcorrección de la alineación y restablecer la tensión ligamentosa adecuada, con una laxitud fisiológica de los espacios. Es aconsejable buscar una apertura en varo/valgo de 1-2 mm en extensión y 2-3 mm en flexión.

La característica más importante de esta técnica es el corte tibial, que determina las restantes resecciones óseas. Se trata de un procedimiento en dos fases, realizado con «cuñas» y «separadores» ajustables para evaluar la resección inicial y perfeccionarla, si es necesario, para garantizar la resección tibial mínima adecuada.

Por tanto, los espacios en flexión y extensión se equilibran de forma independiente mediante resecciones óseas femorales adecuadas.

Medacta International

2. PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA

2.1 PLANIFICACIÓN RADIOLÓGICA

Habrá que hacer radiografías anteroposteriores, laterales, de la línea del horizonte y de Rosenberg para determinar la alineación única y la gravedad global de la enfermedad de la rodilla. Las radiografías de esfuerzo en valgo se utilizan para determinar la conformidad del compartimento y la integridad del compartimento medial.

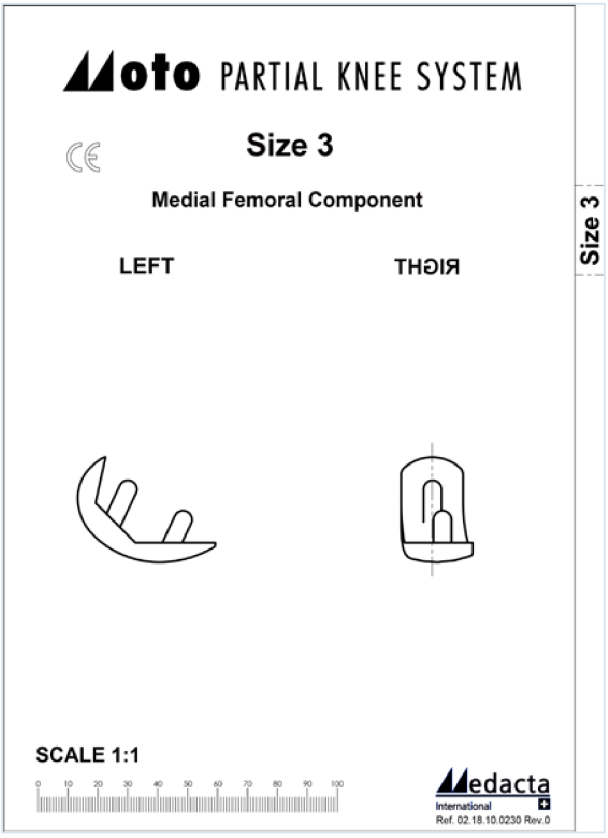
2.2 PLANIFICACIÓN CLÍNICA

Los objetivos son evaluar la localización del dolor, la amplitud de movimiento, la fuerza, la estabilidad ligamentosa y la función patelofemoral.

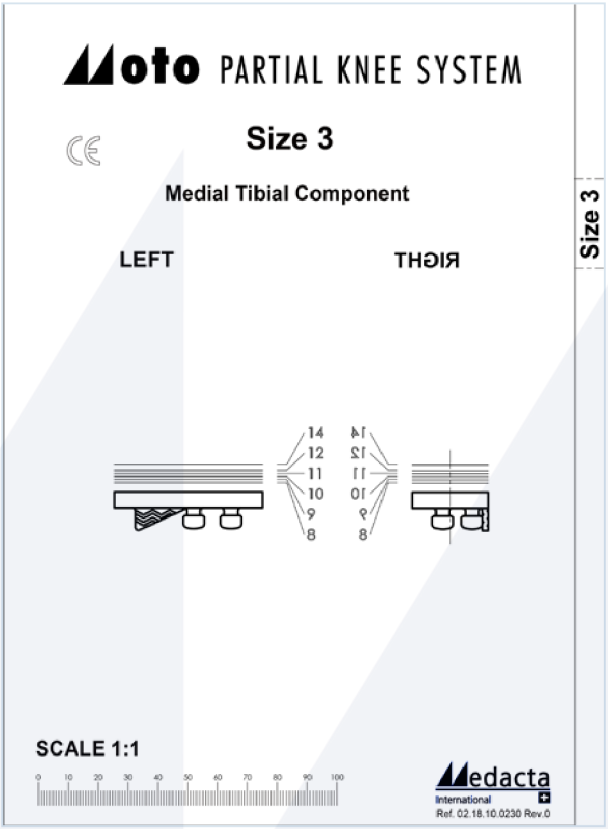
2.3 PLANTILLA DE RADIOGRAFÍA PREOPERATORIA

El tamaño de los componentes femoral y tibial puede estimarse antes de la operación utilizando plantillas de rayos X.

Estas plantillas permiten un factor de aumento del: 100% (1:1, estándar), 110% (especiales) y 115% (especiales).



Plantilla radiográfica — componente femoral



Plantilla radiográfica — componente tibial

3. ABORDAJE QUIRÚRGICO

3.1 POSICIONAMIENTO DE LAS EXTREMIDADES

Con el paciente en posición supina, hay dos opciones habituales para colocar la extremidad:

Soporte de piernas ajustable con la mesa de operaciones estándar: la extremidad inferior se prepara y se coloca libre por debajo del torniquete.

Colocación libre de la pierna: la pierna no operada se coloca en un portapiernas y la pierna operada se coloca colgando libre con unos 15-20 grados de flexión de cadera. La extremidad inferior se prepara y se coloca libre por debajo del torniquete.



1

3.2 INCISIÓN Y EXPOSICIÓN

Con la rodilla a 90 grados de flexión, haga una incisión recta empezando 1 cm por encima del polo superior de la patela. Debe extenderse distalmente hasta la parte medial del tubérculo tibial, y solapar 1/5 medial de la patela. Utilice la disección aguda para exponer la cápsula y los colgajos subcutáneos.

Comience la artrotomía a lo largo del borde medial de la patela y extiéndala distalmente hasta la parte medial del tubérculo tibial. En su extremo superior, la incisión debe extenderse aproximadamente 1 cm en el vasto medial.

> **CONSEJO**
> No dude en ampliar la incisión según sea necesario para aumentar la visualización y/o la protección de los tejidos blandos.

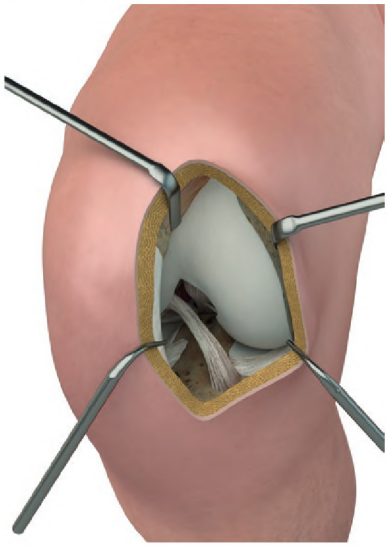


2

Cambie el retractor superficial por un retractor profundo. Haga una resección del cuerno anterior del menisco medial y la porción medial de la almohadilla de grasa retropatelar. Esto expondrá el compartimento medial y la muesca intercondilar.

Realice una disección mínima a lo largo de la línea articular medial del tendón patelar, medialmente, para permitir la exposición de la meseta tibial y la colocación del retractor. Asegúrese de no interrumpir ninguna fibra del ligamento colateral medial (LCM) superficial.

Examine el ligamento cruzado anterior (LCA) y el compartimento lateral y confirme el patrón de desgaste en la meseta tibial antero-medial y el cóndilo femoral medial.



3

3.3 RESECCIÓN DE OSTEOFITOS

Elimine los osteofitos del cóndilo femoral medial, del borde medial de la patela y de la escotadura intercondílea, de forma que no interfieran en la elección del tamaño del implante ni en la evaluación de la estabilidad articular (tenting del LCM). Es fundamental eliminar el osteofito de muesca siempre presente en el borde lateral del cóndilo femoral medial. Esto crea espacio para introducir la hoja de sierra sagital en la muesca intercondilar durante la resección tibial, y es necesario para permitir la trayectoria correcta del corte sagital.



4

4. RESECCIÓN TIBIAL

4.1 MONTAJE Y COLOCACIÓN DE LA GUÍA DE ALINEACIÓN EXTRAMEDULAR

El sistema extramedular tibial consta de los componentes siguientes:



5

- **A** — Guía de corte tibial: derecha o izquierda
- **B** — Cuña (0 mm, +1 mm, +2 mm, +3 mm, +4 mm, +5 mm): derecha o izquierda
- **C** — Guía extramedular: parte distal
- **D** — Pinza de sujeción (cuerpo + tornillo de regulación v/v + correa de silicona)

Presionando el botón distal de la guía extramedular — parte distal (C), deslice el cuerpo de la pinza de sujeción (D) sobre la cola de milano distal «en forma de D» de la guía extramedular. Suelte el botón, introduzca el tornillo para efectuar la regulación en varo/valgo y apriete el pomo para sujetar provisionalmente la pinza.

Presionando el botón proximal frontal de la guía extramedular — parte distal (C), introduzca la guía de corte tibial del lado operativo correcto (A) en el extremo proximal de la guía extramedular — parte distal (C) y suelte el botón.



6 *Botón proximal frontal · Botón distal*

Deslice la cuña más gruesa (0 mm) en las pistas específicas de la parte superior de la guía de corte tibial. Fije la cuña en la parte superior de la guía de corte tibial, girando (con el destornillador) el tornillo específico hacia la derecha (guía derecha) o en el sentido contrario (guía izquierda).



7 *Tornillo de bloqueo para fijar la cuña*

Coloque el conjunto en la tibia. Fije la parte distal del conjunto colocando la correa de silicona alrededor del tobillo, proximalmente a los maléolos. Procure que la pinza de sujeción apunte hacia el centro del tobillo y que la guía de corte esté centrada en la tibia proximal.



8

4.2 AJUSTE DEL NIVEL DE RESECCIÓN TRANSVERSAL DE LA TIBIA

El sistema extramedular tibial permite efectuar el ajuste en los tres planos: coronal (altura), frontal (varo/valgo) y sagital (inclinación). Los números indicados en el cuerpo de la pinza maleolar permiten una referencia que no tiene un significado anatómico directo pero que podría ser útil para el reposicionamiento o el reajuste.

Desenrosque el pomo y ajuste el varo/valgo trasladando la guía medial o lateralmente. Para conseguir una alineación neutra, coloque la guía paralela al eje tibial (espina tibial respecto al centro del astrágalo, ligeramente medial respecto al punto medio del tobillo) y apriete el pomo para fijarla en su sitio.



9

La altura se ajusta con el botón superior. Pulse el botón y deslice la guía de corte tibial para ajustar la altura (se admite una graduación en incrementos de 2 mm).



10

Utilice un ala de ángel para indicar si:

- El corte tibial resecará una oblea conservadora de hueso justo por debajo del defecto más bajo
- El corte coincide con la pendiente anatómica posterior de la tibia



11

Si se necesita más o menos inclinación, ésta puede ajustarse pulsando el botón distal y deslizando la guía extramedular en sentido anteroposterior a lo largo de la varilla de la pinza de sujeción (se admite una graduación en incrementos de 2 mm). Al cambiar la inclinación, compruebe si la pinza de sujeción sigue apuntando al centro del tobillo.

La guía tibial tiene 3 grados de inclinación posterior incorporada. Si la varilla es paralela a la cresta tibial, el corte tibial resultante tendrá una inclinación de 3 grados.



12

CONSEJO

Adapte la inclinación anatómica del paciente, evitando una inclinación tibial excesiva (lo ideal es que la inclinación tibial no supere los 5 grados).

CONSEJO

En general, el ajuste de la inclinación en el número «13» indicado en la varilla de la pinza maleolar es un buen punto de partida; ajuste a partir de ahí según sea necesario.

Se puede colocar un ala de ángel en el plano de la cuña de 0 mm para confirmar el nivel y la pendiente de resección deseados. Cuando el ajuste de la altura, la alineación frontal y la inclinación posterior se consideren satisfactorios, fije la guía con un pin de cabeza roscada simple utilizando uno de los orificios del pasador marcados con una línea (verde en la figura 13). Añada otro pasador si se precisa una mejor fijación.



13 *Orificio de fijación de referencia lateral*

- Orificios de referencia para la fijación
- Orificios de reposicionamiento (+3 mm recortados)

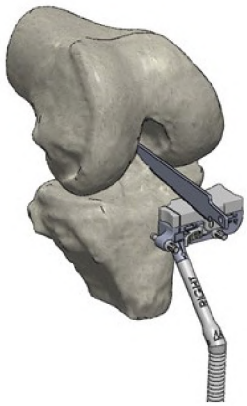
CONSEJO

Si es posible, utilice la opción de pasador lateral porque el orificio se situará en el lateral del corte de sierra sagital.

PRECAUCIÓN

Procure que la trayectoria de la hoja de sierra no gire hacia el interior. Además, la hoja no debe estar en una posición lateral respecto al vértice de la espina tibial medial (normalmente 2-3 mm lateral a la pared lateral del cóndilo femoral medial).

4.3 RESECCIÓN SAGITAL



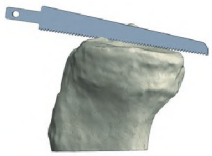
14

Con la rodilla flexionada, coloque la punta de una sierra recíproca de una cara en la muesca contra la pared lateral del cóndilo femoral medial, y justo debajo del ligamento cruzado posterior (LCP).

Corte a mano alzada cerca del pico de la espina tibial medial. Es imprescindible mantener la hoja de sierra paralela a la guía para que no se produzcan muescas en la corteza posterior de la tibia. La hoja de sierra debe hacer contacto con la guía tibial primero en sentido anterior y luego efectuar el corte en sentido posterior. Esto ayuda a evitar las muescas posteriores y la fractura de la meseta tibial.



15



16

CONSEJO

Este corte puede interrumpir las fibras más mediales del LCA cuando se insertan en la tibia, pero no debe cortar el cuerpo principal del propio ligamento.

PRECAUCIÓN

Evite los siguientes factores que pueden contribuir al riesgo de fractura tibial postoperatoria:

- Efectuar una muesca en la corteza posterior durante el corte sagital
- Posicionar el corte sagital demasiado medial respecto a la punta de la espina tibial anterior
- Crear más de dos orificios para clavos en la tibia proximal y/o alineados con el corte sagital
- Realizar una resección excesivamente profunda de la tibia en el hueso metafisario más blando

4.4 RESECCIÓN TIBIAL TRANSVERSAL

Coloque un retractor en posición medial para proteger el LCM. Procure que la hoja de sierra oscilante sea coplanaria a la superficie de la guía de corte. Realice el corte transversal de la tibia, deteniéndose en sentido lateral cuando se llegue al corte sagital. Procure no cortar por debajo de la espina tibial.



17



18

CONSEJO

Para no cortar por debajo de la espina tibial, la hoja de sierra sagital recíproca libre puede colocarse en el corte sagital del hueso.

Se puede ver que la oblea ósea «salta» una vez que se han realizado las resecciones sagital y transversal. Retire la oblea ósea y realice un corte de limpieza en las zonas protuberantes que queden directamente a la vista. Examine el grosor y la inclinación de la oblea ósea.

Ponga la rodilla en extensión y compruebe que la resección del hueso tibial cubre completamente el cóndilo femoral medial. De no ser así, evalúe la necesidad de añadir más rotación externa al corte sagital, o de lateralizar el corte sagital.

4.5 EVALUACIÓN DEL ESPACIO EN FLEXIÓN Y EXTENSIÓN

Para medir las distancias se dispone de ocho distanciadores de dos caras (rango 4-19), con los tamaños siguientes: 4-5, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19.



19

Con la rodilla a 90 grados de flexión, introduzca el espaciador para determinar el espacio en flexión. Al determinar el grosor del espacio en flexión, elija el espaciador más grueso que se adapte al espacio con poca o ninguna resistencia. Compruebe la alineación en varo/valgo y la inclinación de la resección tibial utilizando la varilla de alineación telescópica a través del separador.



20

Si la primera resección tibial es demasiado conservadora y el separador más fino («4») no puede introducirse en la articulación, vuelva a cortar la tibia reposicionando la guía de corte tibial. Utilice la fila superior de orificios (indicada en azul en la figura 21). Esto permitirá una resección tibial de +3 mm.



21

En este momento, determine el espacio en flexión con separadores. A continuación, coloque la rodilla en extensión completa. Compruebe el espacio en extensión utilizando separadores de la misma manera. El separador correcto es el más grueso que llena el espacio en extensión con poca o ninguna resistencia mientras mantiene una alineación en valgo ligeramente subcorregida.

La información recogida en la evaluación del espacio en flexión y extensión se utilizará para determinar el plan de resección ósea para equilibrar correctamente la rodilla, como se describe a continuación.

El objetivo es una resección distal que permita un espacio tibial definitivo en flexión final de «9», con una apertura en varo/valgo que corresponda a la laxitud deseada. Los autores aspiran a conseguir aproximadamente 2-3 mm de apertura en varo/valgo en flexión.

Es aconsejable establecer un espacio de flexión ideal de «9», ya que proporciona al cirujano una flexibilidad de dimensionamiento intraoperatorio de +/- 1 mm.

4.6 AJUSTE DEL CORTE TIBIAL

Si el espaciador que encaja en flexión es el de «9», no es necesario hacer ninguna otra resección tibial. Si el separador es inferior a «9», se necesita más resección para conseguir el espacio deseado de «9».

Para volver a cortar la tibia proximal, se aplican cuñas a la guía de corte tibial, lo que permite una resección de +1 mm, +2 mm, +3 mm, +4 mm o +5 mm. Se obtiene una resección de +6 mm cortando directamente sobre la guía de corte tibial, sin aplicar ninguna cuña.



22

Determine el grosor adecuado de la cuña que se utilizará para recortar la tibia proximal de acuerdo con la siguiente fórmula:

Espaciador + espesor de la cuña = «9»

Con la ayuda de la palanca frontal de la guía de corte tibial, retire la cuña de 0 mm. A continuación, aplique la cuña adecuada sobre la guía de corte tibial. Coloque un retractor en una posición medial para proteger el LCM.

Si la resección es superior a 1 milímetro, haga primero el corte sagital y luego el corte transversal. Recorte hasta que el espacio en flexión sea «9».



23 *Palanca frontal para la cuña*

EJEMPLO

Después de la resección inicial de la tibia, el espacio en flexión se mide en «6». Retire la cuña de 0 mm de la guía tibial y sustitúyala por la cuña de +3 mm, lo que permitirá otro corte tibial de 3 mm. Esto dará como resultado un espacio en flexión de «9».

[«6» separador] + [+3 mm cuña] = «9» espacio en flexión



24 *separador «6»*



25 *cuña +3 mm*



26 *separador «9»*

Utilice los separadores para confirmar los espacios y la alineación después de realizar un recorte tibial. Cuando la resección de la tibia se considere satisfactoria, retire el/los pasador(es) y la plantilla tibial.

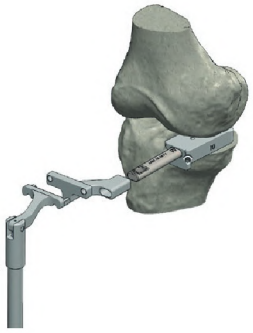
OPCIÓN

Si se desea una menor resección tibial, véase el apartado 5.4 para revisar las opciones de precorte femoral para aumentar la brecha de flexión mediante resecciones condilares femorales posteriores.

5. RESECCIÓN FEMORAL

5.1 COMPROBACIÓN DE LA ALINEACIÓN EN EXTENSIÓN

Para comprobar la línea articular y la alineación de los implantes se dispone de los instrumentos siguientes:

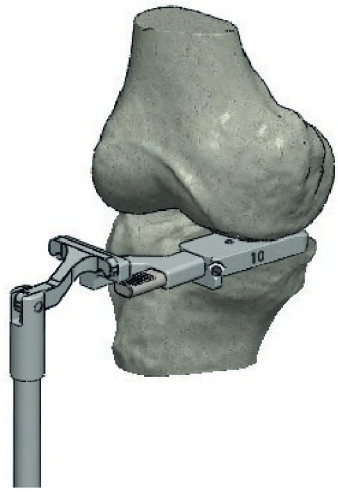


27

- **A** — Espaciadores distales: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- **B** — Conector para el espaciador distal
- **C** — Conector de alineación de desplazamiento
- **D** — Varilla telescópica de alineación

Coloque la pierna completamente en extensión e introduzca el grosor del espaciador distal adecuado en la articulación hasta que el labio anterior deje de estar en contacto con la cara anterior de la tibia. El grosor del espaciador distal debe ser al menos igual al grosor del espaciador determinado previamente en extensión. El espaciador debe introducirse completamente en el espacio articular y asentarse a ras de las superficies de la tibia reseccionada, tanto en el corte sagital como en el transversal.

Monte el conector (B) y el corrector de alineación (C) en el separador (A). Introduzca la varilla de alineación telescópica (D) en el offset, centrándola en la tibia. Evalúe la alineación procurando que la barra telescópica esté alineada con el centro del tobillo y se aproxime al centro de la cadera (el grado de subcorrección de la alineación se da en función de la anatomía del paciente).



28

Compruebe que la rodilla no esté sobrecorregida en valgo, y permita la laxitud deseada.

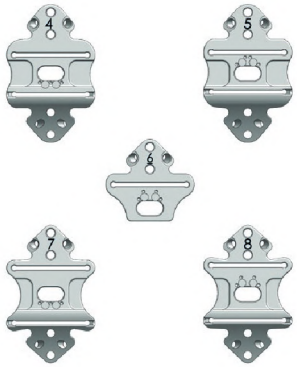
> **AVISO**
> La plantilla tibial se ha diseñado con una inclinación posterior incorporada de 3°. El conector del separador distal tiene un ángulo de 3° con respecto al separador distal para compensar el ángulo de flexión-extensión.

Retire la varilla telescópica y el conector de alineación de offset.

5.2 RESECCIÓN DISTAL

La resección distal del fémur puede ajustarse en función de las necesidades de equilibrar los espacios.

Las guías de corte distal se encuentran con los grosores de resección siguientes: «4»/«5», «6» (correspondiente al grosor distal del componente femoral) y «7»/«8».



29

- Orificios de fijación y reposicionamiento de referencia
- Orificios de fijación oblicua

El objetivo es una resección distal que permita un espacio en extensión final de «15», con una apertura en varo/valgo que corresponda a la laxitud deseada. Los autores aspiran a conseguir aproximadamente 1-2 mm de apertura en varo/valgo en extensión.

El espacio en extensión objetivo «15» refleja el grosor combinado del componente femoral distal («6»), la bandeja tibial «9» y el grosor del polietileno.

OPCIÓN

Pueden utilizarse las guías de corte distal independientes para 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm y 8 mm como solución opcional (figura 30).



30 *Guías de corte distal independientes 4-8 mm*

- Orificios de fijación y reposicionamiento de referencia
- Orificios de fijación oblicua

PRECAUCIÓN

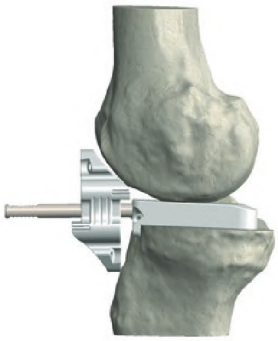
Los orificios de fijación de referencia, los orificios de reposicionamiento y los orificios de fijación oblicua de las guías de corte distales autónomas no coinciden con los de las guías de corte distales estándar resaltados en la figura 29.

Seleccione el grosor de la guía de corte distal que, cuando se combina con el grosor del separador distal validado, da como resultado un espacio en extensión de «15». Ensámblela sobre el conector del separador distal.

EJEMPLO

Después de la resección de la tibia, el espacio en flexión se mide en «10». Elija la guía de corte distal de 5 mm. Esto dará como resultado un espacio en extensión de «15».

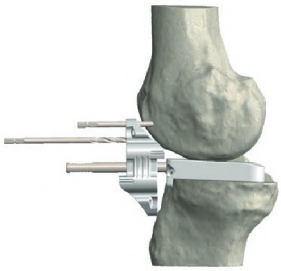
[«10» espaciador distal de la tibia solamente] + [«5» resección distal] = «15» espacio en extensión (tibia más fémur distal)



31

Ajuste la rotación confirmando que el bloque del separador distal está a ras del corte sagital.

Aplique una carga axial para asegurarse de que el LCM no está suelto y para acomodar la laxitud deseada. Fije la guía de corte mediante dos pines lisos sin cabeza insertados en los orificios centrales paralelos (verde en la figura 29 y amarillo en la figura 30). Si se desea una mayor fijación, se puede añadir un pin con cabeza roscada en uno de los orificios oblicuos (azul en la figura 29 y morado en la figura 30).



32

Con el retractor LCM colocado en su sitio, realice la resección femoral distal a través de la ranura de captura de la sierra.

Tras realizar el corte inicial en extensión, retire la barra de conexión y el bloque del separador distal. Flexione la rodilla 90° y realice la resección distal para evitar una lesión inadvertida del LCA y/o del LCM. Es imprescindible retirar la barra de conexión del bloque espaciador distal antes de flexionar la rodilla.

Medacta International



33

5.3 CONTROL DEL ESPACIO EN EXTENSIÓN

Retire el bloque de corte distal deslizándolo sobre los pasadores.

Con la rodilla en extensión, compruebe el espacio en extensión y la estabilidad de la rodilla mediante el separador «15», simulando el grosor total del implante objetivo (fémur distal y bandeja tibial «9» más polietileno).

Compruebe que la apertura en varo/valgo corresponde a la laxitud deseada. Los autores aspiran a conseguir aproximadamente 1-2 mm de apertura en varo/valgo en extensión.

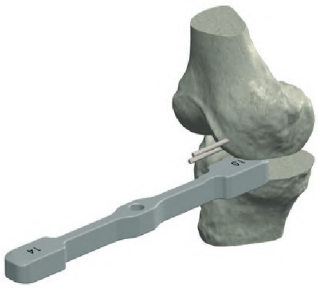
Compruebe que la alineación sea correcta utilizando la barra de alineación telescópica.

CONSEJO

Para facilitar la extracción de la barra de conexión, introduzca un destornillador en el orificio y tire de la barra de conexión hacia fuera.



34



35

Si es necesario, vuelva a cortar el fémur distal utilizando la guía de corte distal adecuada colocada en los pines paralelos anteriores.



36

Tras realizar la resección distal y lograr la separación y la alineación correctas de la extensión, retire los pines.

5.4 PRECORTE DEL CÓNDILO FEMORAL POSTERIOR

Después de la resección tibial inicial, se puede utilizar un precorte del cóndilo femoral posterior (CFP) para conseguir el espacio en flexión objetivo de «9», en lugar de o en combinación con un nuevo corte tibial asistido por cuñas.

Existen dos casos en los que un corte previo es realmente útil:

- **1** — En una rodilla en la que el espacio en flexión es significativamente más estrecho que el espacio en extensión
- **2** — En una rodilla donde se prioriza la preservación del hueso tibial minimizando la profundidad de la resección tibial

Se puede realizar un precorte posterior de 1 mm simplemente raspando el vértice posterior del cartílago en el cóndilo femoral. Se puede realizar un precorte posterior de 2 mm o 3 mm utilizando las guías de raspado posteriores específicas.



37



38

EJEMPLO 1

Después de la resección inicial de la tibia, el espacio en flexión se mide en «7» y el espacio en extensión se mide en «10». Prever un precorte femoral de +2 mm para alcanzar el objetivo de «9» de espacio en flexión sin aumentar más el espacio en extensión y, al mismo tiempo, reducir la diferencia entre los espacios en flexión y extensión.

[«7» separador] + [+2 mm CFP] = «9» separación de flexión

EJEMPLO 2

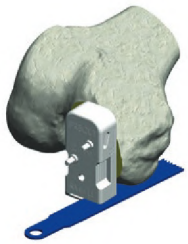
Después de la resección inicial de la tibia, el espacio en flexión se mide en «5» y el espacio en extensión se mide en «7». Seleccione la cuña +2 para hacer la resección de la tibia adicional y prepare un precorte femoral de +2 mm para obtener la flexión objetivo «9».

[«5» separador] + [+2 mm cuña] + [+2 mm CFP precorte] = «9» espacio en flexión

El precorte de 2 mm o 3 mm debe realizarse después de la resección femoral distal, lo que proporciona un posicionamiento más estable de la guía de raspado en el fémur. Tenga en cuenta esta opción a la hora de planear el recorte de la tibia necesario para conseguir la distancia deseada de flexión «9».

Si se ha planificado un precorte de 2 mm o 3 mm para lograr un espacio de flexión «9», coloque la guía de raspado elegida en la superficie de corte del fémur distal y la placa posterior en contacto con el cóndilo posterior.

Fije la guía con pasadores y corte a través de la ranura de captura de la sierra.



39

Después de realizar el precorte, vuelva a comprobar el espacio en flexión con los separadores.

5.5 DIMENSIONAMIENTO DEL FÉMUR Y CORTE POSTERIOR Y CHAFLÁN

Existen calibradores femorales para determinar el tamaño del componente femoral y la posición anteroposterior del implante.

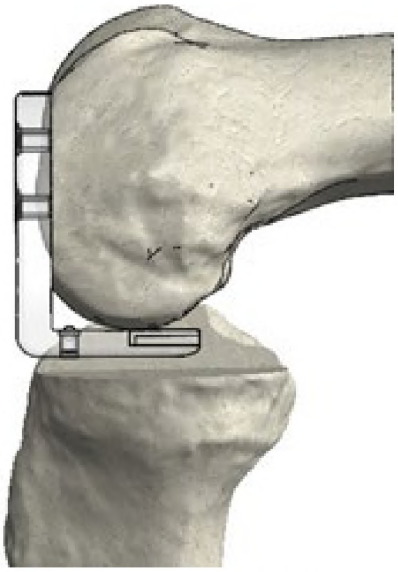


40

Hay un calibrador femoral por talla, en versiones derecha e izquierda.

El contorno exterior de los medidores coincide con el contorno del implante correspondiente, tanto en sentido medio-lateral como anteroposterior.

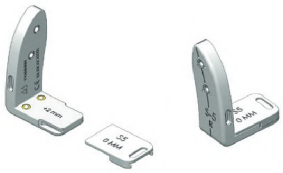
El calibrador admite una resección de +2 mm con respecto al grosor del implante (descompresión posterior). De este modo, el componente femoral se anterioriza en 2 mm y se abre el espacio en flexión 2 mm, ya que se tiene en cuenta el cartílago intacto en el espacio en flexión.



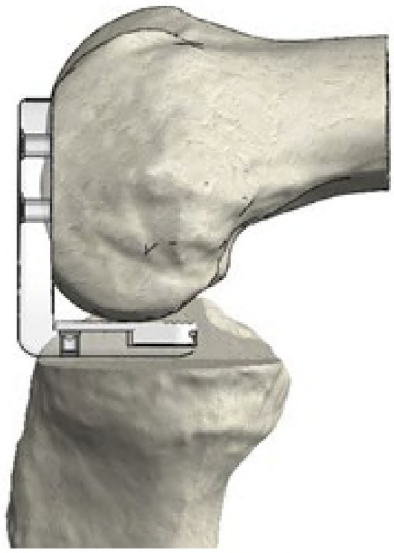
41 *Descompresión posterior (sin cuña)*

OPCIÓN

Se dispone de una cuña de 2 mm de grosor que se acopla a los calibradores femorales, admitiendo una resección que equivale al grosor del implante (resección muy precisa del cóndilo femoral posterior).



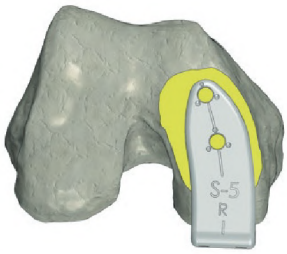
42 *cuña · 2 mm*



43 *Resección de precisión (con cuña)*

Con la rodilla flexionada, aplique el calibrador adecuado al corte femoral distal. El calibrador debe colocarse a ras de la superficie de resección distal y la placa posterior debe colocarse en contacto con el cóndilo posterior.

Procure que no haya ningún saliente medial y que el bloque tenga aproximadamente 2 mm de superficie de corte en la punta superior.



44 *2 mm*

CONSEJO

Si está entre dos tamaños, elija el más pequeño. De esta forma, se evita el saliente del compartimento y el pinzamiento patelar.

Confirme la alineación rotacional y la posición medio/lateral.

CONSEJO

Habrá la oportunidad de ajustar la posición medio/lateral después de la reducción de la prueba.

Una vez seleccionada y colocada la medida adecuada, taladre el orificio superior con la broca con tope de 3,2 mm. A continuación, fije la posición del calibrador femoral con un pasador. Puede seguir ajustándose la rotación del componente.

Una vez obtenida la cobertura idónea, perfore el orificio de fijación inferior correspondiente al lado correcto de la pierna operada.



45

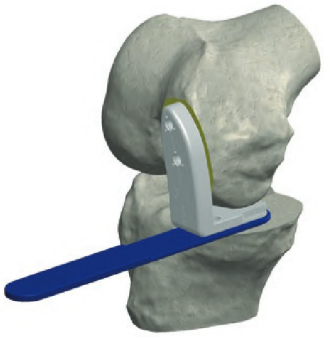
Medacta International

CONSEJO

Para aumentar la estabilidad del calibrador mientras se fija la pieza, se puede colocar el espaciador de 2 o 3 mm entre la superficie inferior del calibrador y el plano de resección tibial.



46



47

Retire el pin y el espaciador y coloque la guía de corte posterior del tamaño correspondiente.

Los componentes femorales están diseñados según tres grupos: tamaños 1-2, 3-7 y 8-10. Los grupos de tamaños de fémur se diferencian por tener espesores de chaflán crecientes para añadir resistencia mecánica a los tamaños más grandes.

Se ofrecen guías de corte posteriores para cada gama de tamaños en versiones derecha e izquierda.



48



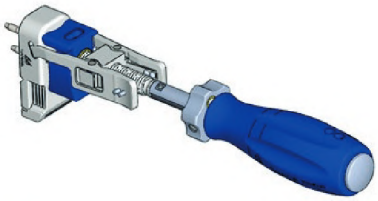
49 *Posicionamiento de los pasadores incorporados*

- Orificios de fijación
- Orificios de reposicionamiento de +2 mm para los pasadores incorporados

Coloque la guía insertando los pasadores incorporados en los dos orificios perforados previamente mediante el calibrador femoral. El bloque de corte puede sujetarse y posicionarse en el hueso mediante el impactador femoral — martillo deslizante.

Monte la guía de corte posterior en el impactador femoral. Abra el impactador femoral girando el mango hacia la izquierda. Aplique presión para abrir las palancas y fije el impactador femoral (con el grabado «TOP» hacia abajo) en las bolsas laterales situadas en la guía de corte posterior. A continuación, suelte la presión sobre las palancas.

Gire el mango del impactador femoral hacia la derecha hasta que el deslizador azul esté firmemente en contacto con la guía de corte posterior. A continuación, coloque la guía de corte posterior sobre el hueso. Para garantizar un buen contacto entre la guía de corte posterior y la superficie de resección distal, desbloquee el anillo del impactador y utilice el martillo deslizante integrado para impactar la guía en el hueso.



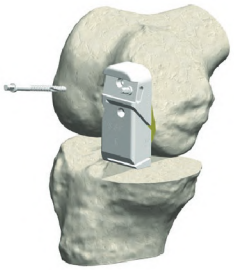
50

La impactación también puede realizarse utilizando un mazo en el extremo del mango, procurando no utilizar una fuerza excesiva.



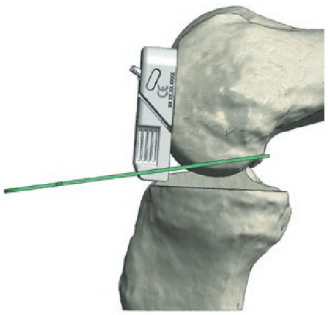
51

Retire el impactador y compruebe que la guía de corte posterior está perfectamente en contacto con la resección distal. Fije la posición de la guía de corte con un pasador de cabeza roscada corta (orificio A de color verde indicado en la figura 52).



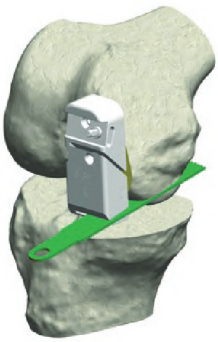
52

Con la rodilla flexionada, y el retractor del LCM en su posición, realice primero el corte posterior a través de la ranura posterior del bloque de corte (indicado en verde en la figura 53).



53

A continuación, realice la resección del chaflán posterior a través de la ranura del chaflán del bloque de corte (indicado en azul en la figura 54).



54

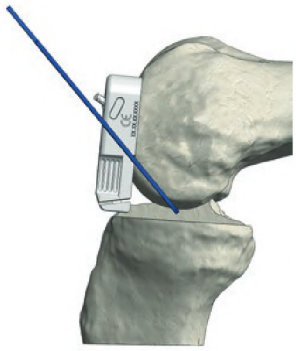
Retire el pasador y el bloque de corte y confirme los cortes. Coloque el componente femoral de prueba en el hueso y compruebe si las resecciones coinciden con el perfil interno del componente femoral.

PRECAUCIÓN

Después de realizar las resecciones femorales, compruebe si todas las superficies son planas. Elimine los osteofitos posteriores restantes, ya que podrían limitar la flexión o la extensión, y el resto del menisco medial.

Si es necesario reducir el tamaño del 3 al 2 o del 8 al 7, habrá un ligero espacio en el chaflán que habrá que rellenar con cemento.

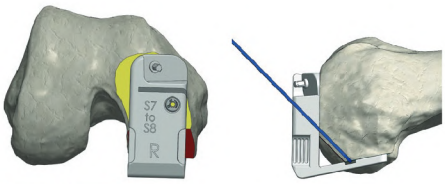
Si se necesita un aumento de tamaño del 2 al 3 o del 7 al 8, habrá que volver a cortar el chaflán. Dos guías de recortado específicas (versiones derecha e izquierda) permiten efectuar el recorte del chaflán para adaptar las resecciones a un tamaño femoral mayor. En los demás casos de aumento de tamaño esta fase no es necesaria.



55

Coloque la guía de recortado del chaflán posterior a ras de las superficies de corte distal y posterior, y fíjela con un pin y un tornillo. Realice el recorte del chaflán a través de la ranura.

6. ACABADO TIBIAL

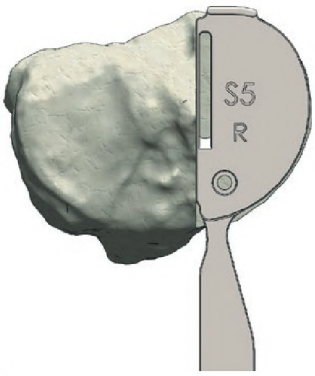


56 57 Tornillo · Pasador

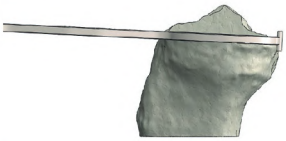
6.1 DIMENSIONAMIENTO DE LA TIBIA Y PREPARACIÓN DE LA QUILLA

Evalúe el tamaño de la tibia utilizando las plantillas tibiales. Existen cuatro plantillas tibiales, cada una de las mismas con dos tamaños (1-2, 3-4, 5-6 y 7-8). Coloque la plantilla en la superficie reseccionada de la tibia. El borde recto debe apoyarse en la superficie creada por el corte sagital y el gancho posterior estar en contacto con la corteza tibial posterior.

Seleccione la plantilla que cubra mejor la tibia proximal reseccionada en las dimensiones anteroposterior y medio-lateral. El objetivo es cubrir la mayor parte posible de la tibia, sin que sobresalga. Cualquier margen de voladizo anterior/posterior debe ser anterior.



58



59

CONSEJO

Si el componente femoral parece excesivamente grande en comparación con el tamaño tibial, evalúe el corte sagital. Considere la posibilidad de lateralizar o añadir rotación externa al corte sagital, si conviene, para ganar tamaño de componente tibial.

PRECAUCIÓN

Es muy importante tener el gancho contra la corteza tibial posterior. Esto ayudará a evitar la ruptura de la corteza posterior mientras se prepara la quilla.

Una vez alcanzada la cobertura idónea, con la plantilla tibial adecuada a ras de la superficie tibial, introduzca un tornillo de cabeza corta en el orificio de fijación anterior para fijar la posición del calibrador de tibia. El tornillo está en la misma posición que el pivote anterior del implante tibial definitivo.



60

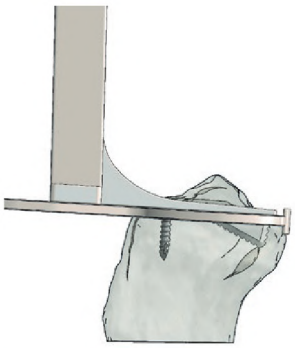
Para preparar la quilla para el implante de prueba y el definitivo, utilice el impactador introduciendo su quilla en la ranura correspondiente del calibrador de plantilla tibial. Compruebe si el impactador de la preparación de la quilla se asienta a ras de la superficie del calibrador de la plantilla tibial. Golpee con el martillo en la parte superior del impactador.



61



62



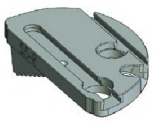
63

CONSEJO

Si el hueso está esclerótico puede que sea necesario utilizar un osteótomo antes de utilizar el impactador para realizar la preparación de la quilla.

6.2 PREPARACIÓN DE LOS PIVOTES TIBIALES

Retire el tornillo y el calibrador de la plantilla tibial. Seleccione el tamaño correcto de la placa base tibial de prueba con quilla integrada.



64

Monte la prueba tibial en el impactador tibial, deslizando el impactador en el carril dedicado de la placa base de prueba elegida.



65

Flexione la rodilla y coloque la bandeja tibial de prueba en la superficie tibial reseccionada, de modo que la quilla integrada encaje en la ranura que se ha preparado previamente. Golpee ligeramente la placa base tibial para que se asiente a ras de la superficie tibial.



66

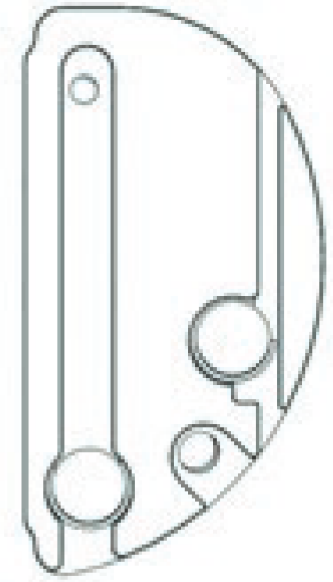
El aspecto medio-lateral de la bandeja tibial de prueba es 1 mm más ancho que el implante definitivo, para evitar el pinzamiento al colocar el inserto. La quilla integrada en el impactador tiene el mismo tamaño de la quilla del implante definitivo.

Retire el impactador tibial.

Fije la bandeja tibial con un tornillo de cabeza corta y perfore los dos orificios del pivote tibial para el pivote de fijación con la broca con tope de 12 mm. Los orificios de los pivotes tienen una inclinación de 5° hacia atrás para facilitar la perforación, evitar el choque con el fémur y permitir la aplicación de un manto de cemento de 1 mm alrededor de los pivotes.



67 *Orificio de fijación del tornillo · Orificios del pivote*



68 *85°*

CONSEJO

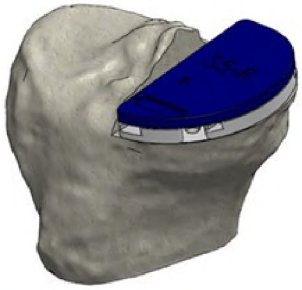
Compruebe si la broca de la espiga tibial está completamente insertada para crear una profundidad suficiente para los pivotes del implante.

7. ENSAYO

Elija el inserto de prueba (normalmente 8 o 9) y deslícelo sobre los raíles de la bandeja base tibial de prueba.



69



70

PRECAUCIÓN

La prueba de 7 mm de grosor solo se propone como artículo por encargo para usarse con el implante E-Cross de polietileno de 7 mm. Antes de realizar la cirugía, compruebe con un representante si el instrumental incluye el inserto de prueba de 7 mm y si se dispone del E-Cross de 7 mm de polietileno para la implantación.

Coloque el componente femoral de prueba en el fémur y ajuste su posición medio-lateral para que se articule lo mejor posible con el centro de la prueba tibial a lo largo de un arco completo de movimiento.

PRECAUCIÓN

Elimine los espolones u osteofitos prominentes en el cóndilo femoral posterior, ya que podrían inhibir la flexión. Procure que no haya ningún saliente posterior del componente femoral. En este caso, se puede optar por un tamaño de fémur más pequeño.

CONSEJO

Determine la posición medio-lateral idónea del fémur de prueba durante la reducción de prueba, viendo el contacto entre el componente femoral y el inserto tibial de prueba.

Tras adquirir la posición idónea, fije la prueba femoral utilizando uno o dos tornillos. Hay dos orificios de fijación posibles para los tamaños de 3 a 10. Hay un orificio de fijación para los tamaños pequeños 1 y 2.



71

Con todos los componentes de la prueba en su sitio, compruebe la estabilidad y el equilibrio de la rodilla en toda la amplitud del movimiento. Evalúe el equilibrio de los ligamentos.

La posición de la línea central grabada en la superficie superior del inserto, comparada con el grabado de la prueba femoral, proporciona una indicación de la posición medio/lateral definitiva del implante.

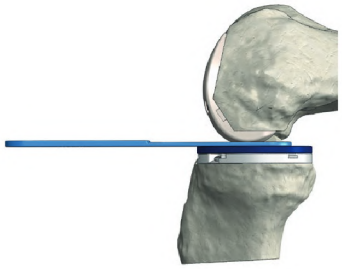
Idealmente, con la tensión en varo-valgo, debe haber una apertura de 1-2 mm en extensión y de 2-3 mm en flexión. Sin embargo, es indispensable que la alineación de la rodilla no se corrija en exceso en valgo.



72

CONSEJO

Introduzca el separador de 2 mm para confirmar los espacios de flexión y extensión y procure que no estén demasiado prietos.



73



74

En el caso de que la reducción de prueba sea tensa en flexión y buena en extensión, una opción es desplazar el componente femoral 2 mm hacia anterior.

Vuelva a colocar el bloque de corte posterior utilizado anteriormente en el fémur distal, fijándolo con el pasador de cabeza roscada anterior (orificio A verde indicado en la figura 75). Perfore los orificios marcados (azul) con la broca con tope de 3,2 mm. Retire el pasador de fijación y el bloque de corte, y vuelva a colocar el bloque de corte en el fémur distal, posicionándolo mediante la inserción de los pasadores incorporados en los orificios recién perforados (azul). Fije el bloque de corte con un pasador de cabeza roscada en el otro orificio (orificio B verde) y repita los cortes posteriores y de chaflán. Esto aumentará 2 mm el espacio en flexión.



75 *Posicionamiento de los pasadores incorporados*

- Orificios de fijación
- Orificios de reposicionamiento de 2 mm — pasadores incorporados

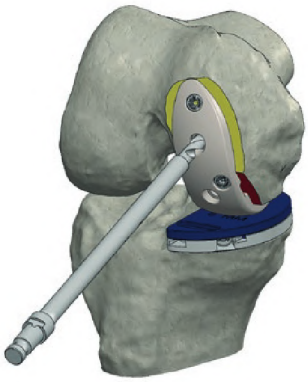
PRECAUCIÓN

Preste especial atención a la cobertura, concretamente si se ha elegido un tamaño de fémur 3 u 8. El desplazamiento anterior de +2 mm podría llevar a la necesidad de reducir el tamaño del fémur a un tamaño 2 o 7, con un chaflán más fino. En este caso habrá un ligero espacio en el chaflán que habrá que rellenar con cemento.

8. ACABADO FEMORAL

Cuando consiga el equilibrio, confirme la posición M/L de la prueba femoral. Combine la guía de perforación con la prueba femoral, introduciendo las dos guías de perforación centrando el cilindro a la altura de los dos orificios de la prueba. Introduzca la broca en la guía de perforación para preparar los pivotes de fijación femoral.

Hay pivotes de prueba para comprobar que se ha preparado correctamente el orificio para el pivote. Utilice el destornillador para facilitar la manipulación de los pivotes.



76



77

Los componentes femorales de tamaño de 1 a 7 tienen dos clavijas de fijación en la misma posición. Los tamaños (8-10) tienen una tercera clavija para aumentar la estabilización.

Chaflán 1: S1 ÷ S2

Chaflán 2: S3 ÷ S7

Chaflán 3: S8 ÷ S10 *(tercer pivote)*



78

9. COMPONENTES DEL IMPLANTE DEFINITIVO

Cuando las pruebas son satisfactorias, se pueden retirar las pruebas femorales y tibiales. A continuación, irrigue la herida y las superficies óseas.

Si hay zonas escleróticas, se pueden preparar con taladros poco profundos para ayudar a la interdigitación del cemento. Superficies óseas secas.

Está prevista la cementación del implante definitivo. El cemento óseo debe prepararse según las instrucciones de uso correspondientes, proporcionadas por el fabricante del cemento.

Implante primero el componente tibial.

9.1 COMPONENTE TIBIAL

Debe limpiarse a fondo la superficie reseccionada. Una vez que el cemento ha alcanzado la viscosidad adecuada según sus instrucciones, debe aplicarse de manera uniforme en la superficie inferior de la bandeja tibial para rellenar las bolsas de cemento.

Aplique el cemento y presione con la pistola o manualmente las superficies óseas y los orificios de los pivotes, procurando no extruir el exceso de cemento hacia atrás.



79

Monte el adaptador de plástico en el impactador tibial. Deslice el impactador hasta que se oiga un clic, lo que confirma que el adaptador está bien bloqueado en el impactador.



80 *Impactador tibial · Adaptador de plástico · Pulse el botón para retirar el adaptador*

Coloque el componente tibial en una posición correcta. Aplique presión, de posterior a anterior, utilizando el impactador específico para permitir la extrusión del cemento en sentido anterior. Coloque la bandeja tibial definitiva en su posición. Retire el exceso de cemento en cada ocasión, comprobando que no queda cemento en la superficie del implante, prestando mucha atención a las ranuras del mecanismo de cierre.



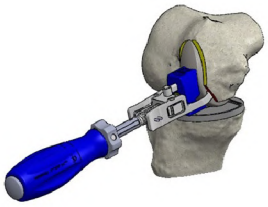
81

Para desmontar el adaptador, pulse el botón situado en la parte posterior del impactador y deslice el adaptador hacia fuera.

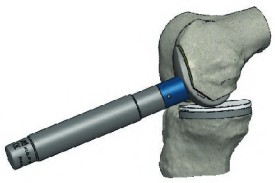
9.2 COMPONENTE FEMORAL

La superficie reseccionada debe limpiarse a fondo. Aplique el cemento en la superficie interna del componente femoral en las bolsas de cemento correspondientes. Aplique el cemento y presione con la pistola o manualmente las superficies óseas y los orificios de las clavijas, procurando no extruir el exceso de cemento hacia atrás.

Enganche el impactador femoral en el componente femoral final y realice la impactación con la rodilla flexionada a 90° utilizando el impactador femoral (grabado TOP hacia arriba). El cemento extruido debe limpiarse bien del fémur, procurando que no quede cemento en la superficie articular. Impactación completa del componente femoral con el impactador femoral.



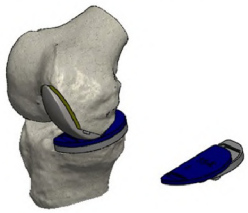
82



83

9.3 COMPONENTE DE INSERTO

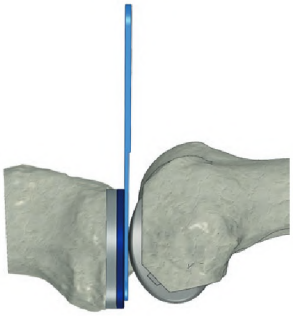
Enganche el inserto de prueba a la placa base y presione ligeramente en extensión.



84

CONSEJO

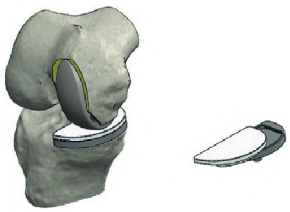
Utilice el separador de plástico de 2 mm para mejorar la presurización. Retire el exceso de cemento.



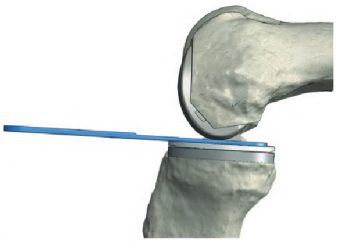
85

Cuando el cemento se haya fraguado, repita la reducción de prueba con el inserto de prueba enganchado en el componente tibial definitivo. Confirme el grosor adecuado del inserto definitivo probando la estabilidad de la rodilla en flexión y extensión para optimizar la amplitud de movimiento, la alineación y la estabilidad.

Retire el exceso de cemento y, una vez fraguado el cemento, implante el inserto de polietileno en la bandeja tibial encajando primero el reborde posterior. A continuación, aplique una presión hacia abajo en el inserto con el separador de plástico de 2 mm.



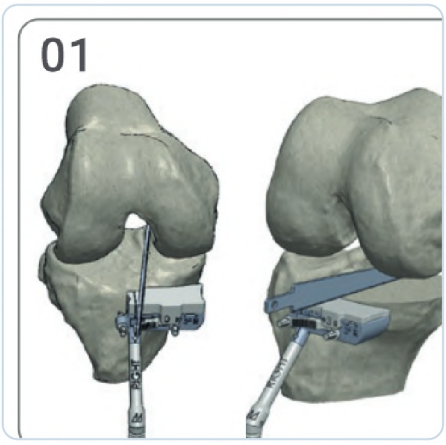
86



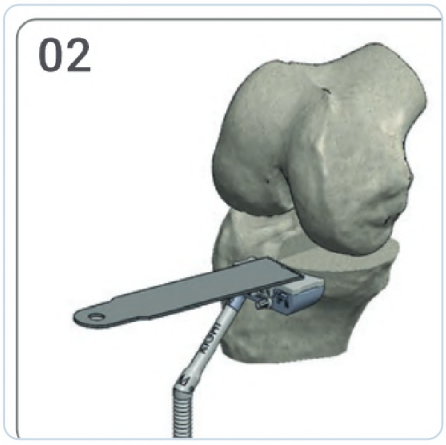
87

Irrigue y cierre la herida de la forma habitual.

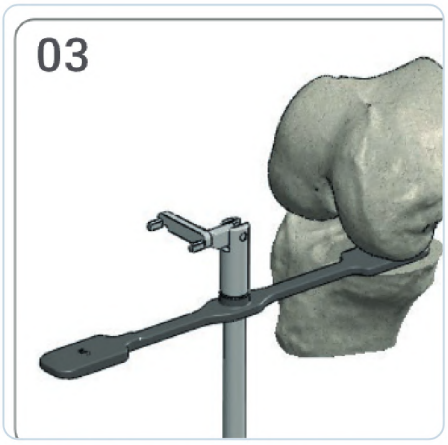
10. RESUMEN DE LAS FASES



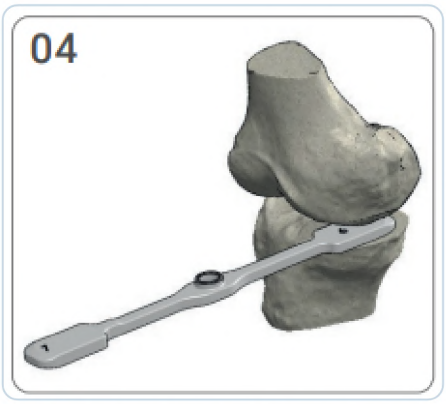
01 · Posicionamiento de la guía de corte tibial. Resección sagital



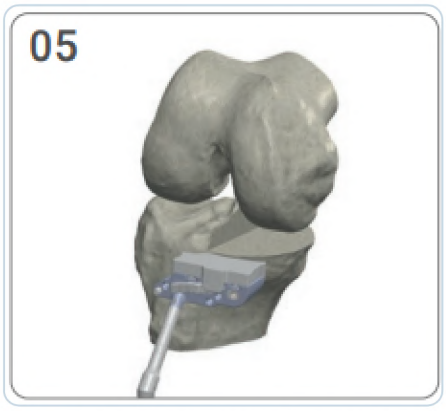
02 · Resección transversal



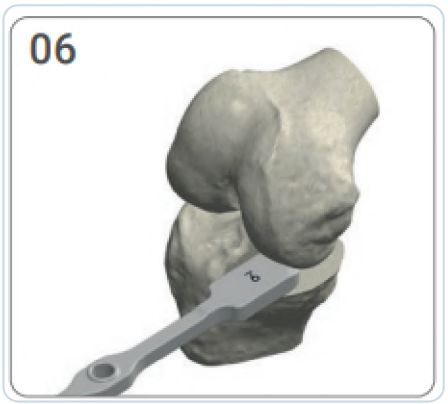
03 · Comprobación del espacio en flexión. Comprobación de la alineación



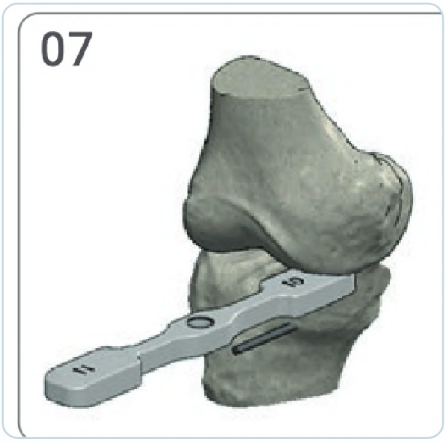
04 · Comprobación del espacio en extensión. Comprobación de la alineación



05 · Recorte tibial para conseguir un espacio en flexión* de «9»



06 · Comprobación del espacio en flexión



07 · Comprobación del espacio en extensión



08 · Colocación del separador distal y de la guía de resección distal



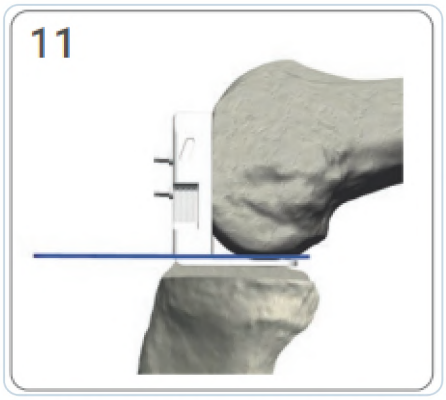
09 · Resección distal

* O espesor deseado

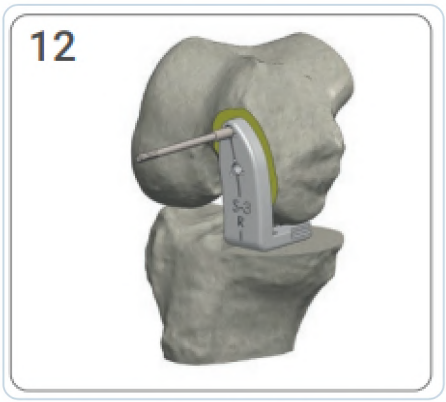
Medacta International



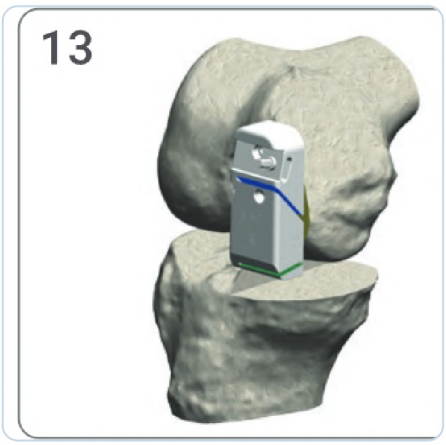
10 · Confirme «15»* espacio en extensión



11 · **Precorte del cóndilo femoral posterior (opción)



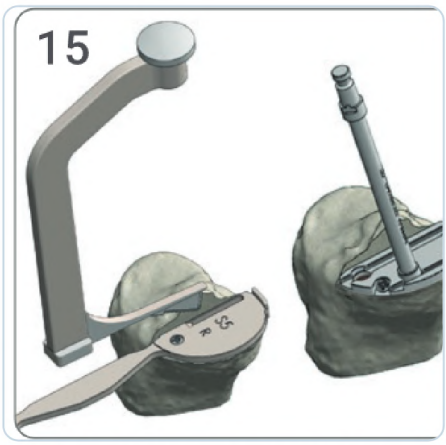
12 · Dimensionamiento del fémur y preparación de los orificios



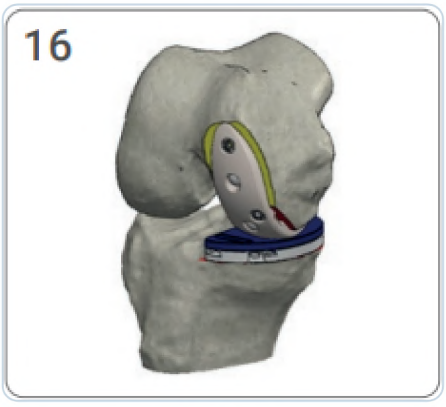
13 · Resecciones posteriores y en chaflán



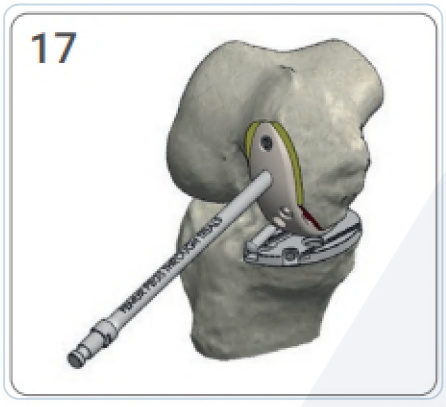
14 · Dimensionamiento de la tibia



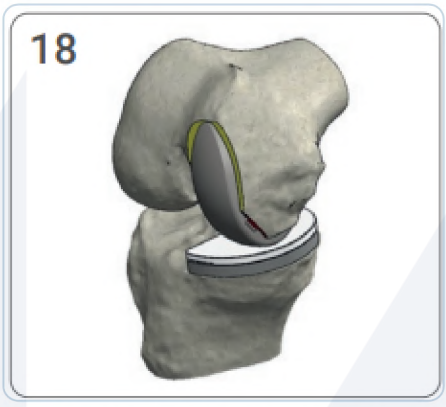
15 · Preparación de la tibia: quilla y pivotes



16 · Ensayo



17 · Ajuste de la posición M/L y preparación de los orificios de los pivotes



18 · Implantación del componente definitivo

* O espesor deseado

** Si desea minimizar o no tener que recortar la tibia, utilice el precorte condilar posterior del fémur para conseguir el espacio en flexión «9»

Medacta International

11. SELECCIÓN DE LOS COMPONENTES PROTÉSICOS — ADAPTACIÓN DEL TAMAÑO

Los insertos tibiales solo deben emparejarse con bandejas tibiales del mismo tamaño. Cualquier inserto tibial puede emparejarse con todos los tamaños de los componentes femorales. Las capacidades de emparejamiento se indican en las tablas 1 y 2.

TABLA 1: CAPACIDADES DE EMPAREJAMIENTO DE LOS INSERTOS TIBIALES Y DE LA BANDEJA TIBIAL

		INSERTO TIBIAL							
	Tamaño	1	2	3	4	5	6	7	8
BANDEJA TIBIAL	1	✓							
	2		✓						
	3			✓					
	4				✓				
	5					✓			
	6						✓		
	7							✓	
	8								✓

TABLA 2: CAPACIDADES DE EMPAREJAMIENTO DE LOS INSERTOS TIBIALES Y DEL COMPONENTE FEMORAL

		INSERTO TIBIAL							
	Tamaño	1	2	3	4	5	6	7	8
COMPONENTE FEMORAL	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	9*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	10*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Tamaño por encargo: compruebe antes de realizar la cirugía con el representante si estos tamaños de fémur existen en el stock del hospital.

Medacta International

12. NOMENCLATURA DE LOS IMPLANTES

COMPONENTE FEMORAL

LADO MEDIAL IZQUIERDO	TAMAÑO	LADO MEDIAL DERECHO
02.18.001LM	1	02.18.001RM
02.18.002LM	2	02.18.002RM
02.18.003LM	3	02.18.003RM
02.18.004LM	4	02.18.004RM
02.18.005LM	5	02.18.005RM
02.18.006LM	6	02.18.006RM
02.18.007LM	7	02.18.007RM
02.18.008LM*	8	02.18.008RM*
02.18.009LM*	9	02.18.009RM*
02.18.010LM*	10	02.18.010RM*

* Tamaño por encargo: compruebe antes de realizar la cirugía con el representante si estos tamaños de fémur existen en el stock del hospital.

COMPONENTE FEMORAL TiNbN

LADO MEDIAL IZQUIERDO	TAMAÑO	LADO MEDIAL DERECHO
02.18.701LM	1	02.18.701RM
02.18.702LM	2	02.18.702RM
02.18.703LM	3	02.18.703RM
02.18.704LM	4	02.18.704RM
02.18.705LM	5	02.18.705RM
02.18.706LM	6	02.18.706RM
02.18.707LM	7	02.18.707RM
02.18.708LM*	8	02.18.708RM*
02.18.709LM*	9	02.18.709RM*
02.18.710LM*	10	02.18.710RM*

BANDEJA TIBIAL

LADO MEDIAL IZQUIERDO	TAMAÑO	LADO MEDIAL DERECHO
02.18.TF1.LM	1	02.18.TF1.RM
02.18.TF2.LM	2	02.18.TF2.RM
02.18.TF3.LM	3	02.18.TF3.RM
02.18.TF4.LM	4	02.18.TF4.RM
02.18.TF5.LM	5	02.18.TF5.RM
02.18.TF6.LM	6	02.18.TF6.RM
02.18.TF7.LM	7	02.18.TF7.RM
02.18.TF8.LM	8	02.18.TF8.RM

Medacta International

INSERTO TIBIAL

LADO MEDIAL IZQUIERDO	TAMAÑO	ALTURA	LADO MEDIAL DERECHO
02.18.IF1.08.LM	1	8	02.18.IF1.08.RM
02.18.IF1.09.LM		9	02.18.IF1.09.RM
02.18.IF1.10.LM		10	02.18.IF1.10.RM
02.18.IF1.11.LM		11	02.18.IF1.11.RM
02.18.IF1.12.LM		12	02.18.IF1.12.RM
02.18.IF1.14.LM		14	02.18.IF1.14.RM
02.18.IF2.08.LM	2	8	02.18.IF2.08.RM
02.18.IF2.09.LM		9	02.18.IF2.09.RM
02.18.IF2.10.LM		10	02.18.IF2.10.RM
02.18.IF2.11.LM		11	02.18.IF2.11.RM
02.18.IF2.12.LM		12	02.18.IF2.12.RM
02.18.IF2.14.LM		14	02.18.IF2.14.RM
02.18.IF3.08.LM	3	8	02.18.IF3.08.RM
02.18.IF3.09.LM		9	02.18.IF3.09.RM
02.18.IF3.10.LM		10	02.18.IF3.10.RM
02.18.IF3.11.LM		11	02.18.IF3.11.RM
02.18.IF3.12.LM		12	02.18.IF3.12.RM
02.18.IF3.14.LM		14	02.18.IF3.14.RM
02.18.IF4.08.LM	4	8	02.18.IF4.08.RM
02.18.IF4.09.LM		9	02.18.IF4.09.RM
02.18.IF4.10.LM		10	02.18.IF4.10.RM
02.18.IF4.11.LM		11	02.18.IF4.11.RM
02.18.IF4.12.LM		12	02.18.IF4.12.RM
02.18.IF4.14.LM		14	02.18.IF4.14.RM

LADO MEDIAL IZQUIERDO	TAMAÑO	ALTURA	LADO MEDIAL DERECHO
02.18.IF5.08.LM	5	8	02.18.IF5.08.RM
02.18.IF5.09.LM		9	02.18.IF5.09.RM
02.18.IF5.10.LM		10	02.18.IF5.10.RM
02.18.IF5.11.LM		11	02.18.IF5.11.RM
02.18.IF5.12.LM		12	02.18.IF5.12.RM
02.18.IF5.14.LM		14	02.18.IF5.14.RM
02.18.IF6.08.LM	6	8	02.18.IF6.08.RM
02.18.IF6.09.LM		9	02.18.IF6.09.RM
02.18.IF6.10.LM		10	02.18.IF6.10.RM
02.18.IF6.11.LM		11	02.18.IF6.11.RM
02.18.IF6.12.LM		12	02.18.IF6.12.RM
02.18.IF6.14.LM		14	02.18.IF6.14.RM
02.18.IF7.08.LM	7	8	02.18.IF7.08.RM
02.18.IF7.09.LM		9	02.18.IF7.09.RM
02.18.IF7.10.LM		10	02.18.IF7.10.RM
02.18.IF7.11.LM		11	02.18.IF7.11.RM
02.18.IF7.12.LM		12	02.18.IF7.12.RM
02.18.IF7.14.LM		14	02.18.IF7.14.RM
02.18.IF8.08.LM	8	8	02.18.IF8.08.RM
02.18.IF8.09.LM		9	02.18.IF8.09.RM
02.18.IF8.10.LM		10	02.18.IF8.10.RM
02.18.IF8.11.LM		11	02.18.IF8.11.RM
02.18.IF8.12.LM		12	02.18.IF8.12.RM
02.18.IF8.14.LM		14	02.18.IF8.14.RM

Medacta International

INSERTO TIBIAL E-CROSS

LADO MEDIAL IZQUIERDO	TAMAÑO	ALTURA	LADO MEDIAL DERECHO
02.18.EIF1.07.LM	1	7	02.18.EIF1.07.RM
02.18.EIF1.08.LM		8	02.18.EIF1.08.RM
02.18.EIF1.09.LM		9	02.18.EIF1.09.RM
02.18.EIF1.10.LM		10	02.18.EIF1.10.RM
02.18.EIF1.11.LM		11	02.18.EIF1.11.RM
02.18.EIF1.12.LM		12	02.18.EIF1.12.RM
02.18.EIF1.14.LM		14	02.18.EIF1.14.RM
02.18.EIF2.07.LM	2	7	02.18.EIF2.07.RM
02.18.EIF2.08.LM		8	02.18.EIF2.08.RM
02.18.EIF2.09.LM		9	02.18.EIF2.09.RM
02.18.EIF2.10.LM		10	02.18.EIF2.10.RM
02.18.EIF2.11.LM		11	02.18.EIF2.11.RM
02.18.EIF2.12.LM		12	02.18.EIF2.12.RM
02.18.EIF2.14.LM		14	02.18.EIF2.14.RM
02.18.EIF3.07.LM	3	7	02.18.EIF3.07.RM
02.18.EIF3.08.LM		8	02.18.EIF3.08.RM
02.18.EIF3.09.LM		9	02.18.EIF3.09.RM
02.18.EIF3.10.LM		10	02.18.EIF3.10.RM
02.18.EIF3.11.LM		11	02.18.EIF3.11.RM
02.18.EIF3.12.LM		12	02.18.EIF3.12.RM
02.18.EIF3.14.LM		14	02.18.EIF3.14.RM
02.18.EIF4.07.LM	4	7	02.18.EIF4.07.RM
02.18.EIF4.08.LM		8	02.18.EIF4.08.RM
02.18.EIF4.09.LM		9	02.18.EIF4.09.RM
02.18.EIF4.10.LM		10	02.18.EIF4.10.RM
02.18.EIF4.11.LM		11	02.18.EIF4.11.RM
02.18.EIF4.12.LM		12	02.18.EIF4.12.RM
02.18.EIF4.14.LM		14	02.18.EIF4.14.RM

LADO MEDIAL IZQUIERDO	TAMAÑO	ALTURA	LADO MEDIAL DERECHO
02.18.EIF5.07.LM	5	7	02.18.EIF5.07.RM
02.18.EIF5.08.LM		8	02.18.EIF5.08.RM
02.18.EIF5.09.LM		9	02.18.EIF5.09.RM
02.18.EIF5.10.LM		10	02.18.EIF5.10.RM
02.18.EIF5.11.LM		11	02.18.EIF5.11.RM
02.18.EIF5.12.LM		12	02.18.EIF5.12.RM
02.18.EIF5.14.LM		14	02.18.EIF5.14.RM
02.18.EIF6.07.LM	6	7	02.18.EIF6.07.RM
02.18.EIF6.08.LM		8	02.18.EIF6.08.RM
02.18.EIF6.09.LM		9	02.18.EIF6.09.RM
02.18.EIF6.10.LM		10	02.18.EIF6.10.RM
02.18.EIF6.11.LM		11	02.18.EIF6.11.RM
02.18.EIF6.12.LM		12	02.18.EIF6.12.RM
02.18.EIF6.14.LM		14	02.18.EIF6.14.RM
02.18.EIF7.07.LM	7	7	02.18.EIF7.07.RM
02.18.EIF7.08.LM		8	02.18.EIF7.08.RM
02.18.EIF7.09.LM		9	02.18.EIF7.09.RM
02.18.EIF7.10.LM		10	02.18.EIF7.10.RM
02.18.EIF7.11.LM		11	02.18.EIF7.11.RM
02.18.EIF7.12.LM		12	02.18.EIF7.12.RM
02.18.EIF7.14.LM		14	02.18.EIF7.14.RM
02.18.EIF8.07.LM	8	7	02.18.EIF8.07.RM
02.18.EIF8.08.LM		8	02.18.EIF8.08.RM
02.18.EIF8.09.LM		9	02.18.EIF8.09.RM
02.18.EIF8.10.LM		10	02.18.EIF8.10.RM
02.18.EIF8.11.LM		11	02.18.EIF8.11.RM
02.18.EIF8.12.LM		12	02.18.EIF8.12.RM
02.18.EIF8.14.LM		14	02.18.EIF8.14.RM

Medacta International

13. NOMENCLATURA DE LA INSTRUMENTACIÓN

Las bandejas siguientes sirven para un reemplazo unicompartimental MOTO® Medial:

REF.	DESCRIPCIÓN
02.18S.201	Rodilla parcial MOTO Medial - Corte tibial y distal
02.18S.202	Rodilla parcial MOTO Medial - Femoral
02.18S.203	Rodilla parcial MOTO Medial - Insertos de prueba

INSTRUMENTO Parcial de Rodilla MOTO Medial - Corte tibial y distal		02.18S.201
REF.	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**
02.18.10.0001	Guía extramedular - parte distal	1
02.18.10.0002	Pinza de sujeción	1
02.18.10.0277	Guía de corte tibial - Derecha	1
02.18.10.0278	Guía de corte tibial - Izquierda	1
02.18.10.0006	Cuña +0 mm - Derecha	1
02.18.10.0007	Cuña +1 mm - Derecha	1
02.18.10.0008	Cuña +2 mm - Derecha	1
02.18.10.0009	Cuña +3 mm - Derecha	1
02.18.10.0010	Cuña +4 mm - Derecha	1
02.18.10.0011	Cuña +5 mm - Derecha	1
02.18.10.0012	Cuña +0 mm - Izquierda	1
02.18.10.0013	Cuña +1 mm - Izquierda	1
02.18.10.0014	Cuña +2 mm - Izquierda	1
02.18.10.0015	Cuña +3 mm - Izquierda	1
02.18.10.0016	Cuña +4 mm - Izquierda	1
02.18.10.0017	Cuña +5 mm - Izquierda	1
02.18.10.0018	Espaciador 4-5 mm	1
02.18.10.0019	Espaciador 6-7	1
02.18.10.0020	Espaciador 8-9	1
02.18.10.0021	Espaciador 10-11	1
02.18.10.0022	Espaciador 12-13	1
02.18.10.0023	Espaciador 14-15	1
02.18.10.0024	Espaciador 16-17	1
02.18.10.0281	Espaciador 18-19	1
02.18.10.0025	Espaciador distal 8	1
02.18.10.0026	Espaciador distal 9	1
02.18.10.0027	Espaciador distal 10	1
02.18.10.0028	Espaciador distal 11	1
02.18.10.0029	Espaciador distal 12	1
02.18.10.0280	Espaciador distal 13	1

Medacta International

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
02.18.10.0030	Separador distal 14	1
02.18.10.0031	Conector para el separador distal	1
02.18.10.0032	Conector de alineación offset - Derecho	1
02.18.10.0260	Guía de corte distal 7-8	1
02.18.10.0259	Guía de corte distal 6	1
02.18.10.0258	Guía de corte distal 4-5	1
02.18.10.0209	Varilla telescópica de alineación	1
02.18.10.0270	Plantilla tibial tamaño 1-2	1
02.18.10.0271	Plantilla tibial tamaño 3-4	1
02.18.10.0272	Plantilla tibial tamaño 5-6	1
02.18.10.0273	Plantilla tibial tamaño 7-8	1
02.18.10.0500	Bandeja tibial de prueba tamaño 1 - Derecha	1
02.18.10.0502	Bandeja tibial de prueba tamaño 2 - Derecha	1
02.18.10.0504	Bandeja tibial de prueba tamaño 3 - Derecha	1
02.18.10.0506	Bandeja tibial de prueba tamaño 4 - Derecha	1
02.18.10.0508	Bandeja tibial de prueba tamaño 5 - Derecha	1
02.18.10.0510	Bandeja tibial de prueba tamaño 6 - Derecha	1
02.18.10.0512	Bandeja tibial de prueba tamaño 7 - Derecha	1
02.18.10.0514	Bandeja tibial de prueba tamaño 8 - Derecha	1
02.18.10.0501	Bandeja tibial de prueba tamaño 1 - Izquierda	1
02.18.10.0503	Bandeja tibial de prueba tamaño 2 - Izquierda	1
02.18.10.0505	Bandeja tibial de prueba tamaño 3 - Izquierda	1
02.18.10.0507	Bandeja tibial de prueba tamaño 4 - Izquierda	1
02.18.10.0509	Bandeja tibial de prueba tamaño 5 - Izquierda	1
02.18.10.0511	Bandeja tibial de prueba tamaño 6 - Izquierda	1
02.18.10.0513	Bandeja tibial de prueba tamaño 7 - Izquierda	1
02.18.10.0515	Bandeja tibial de prueba tamaño 8 - Izquierda	1
02.18.10.0275	Impactador de tibia de prueba	1
02.18.10.0276	Adaptador para impactador de implante tibial	1
02.07.10.0532	Calibre	1
02.18.10.0274	Impactador de quilla	1
02.18.10.0208	Broca para clavijas de tibia	1
02.07.10.4742	Adaptador de pasador Acoplamiento Hudson - Conjunto cónico	1
02.18.10.0206	Destornillador T10	1
02.02.10.0146	Impactador de pasadores	por encargo
02.07.10.4673	Lima	1
02.18.10.0207	Destornillador eléctrico Torx T10	1
02.18.10.0087	Tornillo HA5 - L=20mm	6
02.02.10.0130	Taladro Ø3,2mm L=130mm	1
02.02.10.0145/A	Pin Ø3,2mm L=70mm	por encargo
02.02.10.0145/B	Pin Ø3,2mm L=90mm	por encargo
02.07.10.2295	Pasador Ø3.2mm L=70mm ISO5835 - Mecha de cabeza triangular	3
02.07.10.2294	Pasador Ø3.2 L=40 ISO5835 - Mecha de cabeza triangular	3

Medacta International

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
02.07.10.2297	Pin Ø3.2mm L=70mm ISO5835 - Mecha de cabeza triangular	3
02.07.10.2194	Pin estoque Ø3,2mm L=22mm	por encargo
02.08.10.0120	Pin UKM Ø3.2mm L=55mm	por encargo
02.07.10.4740	Pin roscado Ø3.2mm L=70mm conexión más larga	3
02.07.10.4741	Pin roscado Ø3.2mm L=85mm conexión más larga	por encargo
U40.211.15	Osteótomo angular 15mm / 23cm	1
02.08.10.0003	Ala de ángel	1
02.18.10.0003	Cordón para pinza de sujeción	5
02.18.10.0268	Pivote de prueba	4
02.18.10.0267	Pasador Ø3.2mm L=55mm HA35 - Mecha de cabeza triangular	3
02.18.10.0279	Broca con tope de Ø3,2 mm para pasadores incorporados	1
02.18.10.8001	Rodilla parcial MOTO Medial - Bandeja de corte tibial y distal	1
02.18.10.0336	Guía de corte distal de 4 mm	por encargo
02.18.10.0337	Guía de corte distal de 5 mm	por encargo
02.18.10.0338	Guía de corte distal de 6 mm	por encargo
02.18.10.0339	Guía de corte distal de 7 mm	por encargo
02.18.10.0340	Guía de corte distal de 8 mm	por encargo

Medacta International

INSTRUMENTO de rodilla parcial MOTO Medial - Femoral		02.18S.202
REF.	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**
02.18.10.0036	Espaciador femoral S1 Derecho	1
02.18.10.0037	Espaciador femoral S2 Derecho	1
02.18.10.0038	Espaciador femoral S3 Derecho	1
02.18.10.0039	Espaciador femoral S4 Derecho	1
02.18.10.0040	Espaciador femoral S5 Derecho	1
02.18.10.0041	Espaciador femoral S6 Derecho	1
02.18.10.0042	Espaciador femoral S7 Derecho	1
02.18.10.0043	Espaciador femoral S8 Derecho	por encargo
02.18.10.0044	Espaciador femoral S9 Derecho	por encargo
02.18.10.0045	Espaciador femoral S10 Derecho	por encargo
02.18.10.0261	Guía de corte posterior #1-2 Derecha	1
02.18.10.0263	Guía de corte posterior #3-7 Derecha	1
02.18.10.0265	Guía de corte posterior #8-10 Derecha	por encargo
02.18.10.0063	Guía de recorte del chaflán posterior S2 a S3 - Derecha	1
02.18.10.0065	Guía de recorte del chaflán posterior S7 a S8 - Derecha	por encargo
02.18.10.0376	Fémur de prueba S1 - Derecho	1
02.18.10.0378	Fémur de prueba S2 - Derecho	1
02.18.10.0380	Fémur de prueba S3 - Derecho	1
02.18.10.0382	Fémur de prueba S4 - Derecho	1
02.18.10.0384	Fémur de prueba S5 - Derecho	1
02.18.10.0386	Fémur de prueba S6 - Derecho	1
02.18.10.0388	Fémur de prueba S7 - Derecho	1
02.18.10.0390	Fémur de prueba S8 - Derecho	por encargo
02.18.10.0392	Fémur de prueba S9 - Derecho	por encargo
02.18.10.0394	Fémur de prueba S10 - Derecho	por encargo
02.18.10.0056	Separador de 2-3mm para calibradores femorales	2
02.18.10.1269	Broca para clavijas de fémur	1
02.18.10.0211	Impactador femoral UKA - martillo deslizante	1
02.08.10.0227	Impactador femoral	1
02.18.10.0222	Precorte del cóndilo posterior de 2 mm - RM-LL	1
02.18.10.0224	Precorte del cóndilo posterior de 2 mm - RM-LL	1
02.18.10.0282	Precorte del cóndilo posterior de 3 mm - RM-LL	1
02.18.10.0283	Precorte del cóndilo posterior de 3 mm - RM-LL	1
02.18.10.1304	Guía de perforación	1
02.18.10.0262	Guía de corte posterior #1-2 Izquierda	1
02.18.10.0264	Guía de corte posterior #3-7 Izquierda	1
02.18.10.0266	Guía de corte posterior #8-10 Izquierda	por encargo
02.18.10.0064	Guía de recorte del chaflán posterior S2 a S3 - Izquierda	1
02.18.10.0066	Guía de recorte del chaflán posterior S7 a S8 - Izquierda	por encargo
02.18.10.0046	Calibrador femoral S1 Izquierdo	1
02.18.10.0047	Calibrador femoral S2 Izquierdo	1
02.18.10.0048	Calibrador femoral S3 Izquierdo	1
02.18.10.0049	Calibrador femoral S4 Izquierdo	1
02.18.10.0050	Calibrador femoral S5 Izquierdo	1

Medacta International

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
02.18.10.0051	Calibrador femoral S6 Izquierdo	1
02.18.10.0052	Calibrador femoral S7 Izquierdo	1
02.18.10.0053	Calibrador femoral S8 Izquierdo	por encargo
02.18.10.0054	Calibrador femoral S9 Izquierdo	por encargo
02.18.10.0055	Calibrador femoral S10 Izquierdo	por encargo
02.18.10.0377	Fémur de prueba S1 - Izquierdo	1
02.18.10.0379	Fémur de prueba S2 - Izquierdo	1
02.18.10.0381	Fémur de prueba S3 - Izquierdo	1
02.18.10.0383	Fémur de prueba S4 - Izquierdo	1
02.18.10.0385	Fémur de prueba S5 - Izquierdo	1
02.18.10.0387	Fémur de prueba S6 - Izquierdo	1
02.18.10.0389	Fémur de prueba S7 - Izquierdo	1
02.18.10.0391	Fémur de prueba S8 - Izquierdo	por encargo
02.18.10.0393	Fémur de prueba S9 - Izquierdo	por encargo
02.18.10.0395	Fémur de prueba S10 - Izquierdo	por encargo
02.18.10.0212	Cuña para calibrador femoral S1	1
02.18.10.0213	Cuña para calibrador femoral S2	1
02.18.10.0214	Cuña para calibrador femoral S3	1
02.18.10.0215	Cuña para calibrador femoral S4	1
02.18.10.0216	Cuña para calibrador femoral S5	1
02.18.10.0217	Cuña para calibrador femoral S6	1
02.18.10.0218	Cuña para calibrador femoral S7	1
02.18.10.0219	Cuña para calibrador femoral S8	por encargo
02.18.10.0220	Cuña para calibrador femoral S9	por encargo
02.18.10.0221	Cuña para calibrador femoral S10	por encargo
02.02.10.0788	Extractor de pasadores	por encargo
02.18.10.8002	Rodilla parcial MOTO Medial - Bandeja femoral	1

Medacta International

INSTRUMENTO de rodilla parcial MOTO Medial - Insertos de prueba		02.18S.203
REF.	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**
02.18.10.0110	Inserto de prueba tamaño 1R - 8	1
02.18.10.0111	Inserto de prueba tamaño 1R - 9	1
02.18.10.0112	Inserto de prueba tamaño 1R - 10	1
02.18.10.0113	Inserto de prueba tamaño 1R - 11	1
02.18.10.0114	Inserto de prueba tamaño 1R - 12	1
02.18.10.0115	Inserto de prueba tamaño 1R - 14	1
02.18.10.0116	Inserto de prueba tamaño 2R - 8	1
02.18.10.0117	Inserto de prueba tamaño 2R - 9	1
02.18.10.0118	Inserto de prueba tamaño 2R - 10	1
02.18.10.0119	Inserto de prueba tamaño 2R - 11	1
02.18.10.0120	Inserto de prueba tamaño 2R - 12	1
02.18.10.0121	Inserto de prueba tamaño 2R - 14	1
02.18.10.0122	Inserto de prueba tamaño 3R - 8	1
02.18.10.0123	Inserto de prueba tamaño 3R - 9	1
02.18.10.0124	Inserto de prueba tamaño 3R - 10	1
02.18.10.0125	Inserto de prueba tamaño 3R - 11	1
02.18.10.0126	Inserto de prueba tamaño 3R - 12	1
02.18.10.0127	Inserto de prueba tamaño 3R - 14	1
02.18.10.0128	Inserto de prueba tamaño 4R - 8	1
02.18.10.0129	Inserto de prueba tamaño 4R - 9	1
02.18.10.0130	Inserto de prueba tamaño 4R - 10	1
02.18.10.0131	Inserto de prueba tamaño 4R - 11	1
02.18.10.0132	Inserto de prueba tamaño 4R - 12	1
02.18.10.0133	Inserto de prueba tamaño 4R - 14	1
02.18.10.0134	Inserto de prueba tamaño 5R - 8	1
02.18.10.0135	Inserto de prueba tamaño 5R - 9	1
02.18.10.0136	Inserto de prueba tamaño 5R - 10	1
02.18.10.0137	Inserto de prueba tamaño 5R - 11	1
02.18.10.0138	Inserto de prueba tamaño 5R - 12	1
02.18.10.0139	Inserto de prueba tamaño 5R - 14	1
02.18.10.0140	Inserto de prueba tamaño 6R - 8	1
02.18.10.0141	Inserto de prueba tamaño 6R - 9	1
02.18.10.0142	Inserto de prueba tamaño 6R - 10	1
02.18.10.0143	Inserto de prueba tamaño 6R - 11	1
02.18.10.0144	Inserto de prueba tamaño 6R - 12	1
02.18.10.0145	Inserto de prueba tamaño 6R - 14	1
02.18.10.0146	Inserto de prueba tamaño 7R - 8	1
02.18.10.0147	Inserto de prueba tamaño 7R - 9	1
02.18.10.0148	Inserto de prueba tamaño 7R - 10	1
02.18.10.0149	Inserto de prueba tamaño 7R - 11	1
02.18.10.0150	Inserto de prueba tamaño 7R - 12	1
02.18.10.0151	Inserto de prueba tamaño 7R - 14	1
02.18.10.0152	Inserto de prueba tamaño 8R - 8	1

Medacta International

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
02.18.10.0153	Inserto de prueba tamaño 8R - 9	1
02.18.10.0154	Inserto de prueba tamaño 8R - 10	1
02.18.10.0155	Inserto de prueba tamaño 8R - 11	1
02.18.10.0156	Inserto de prueba tamaño 8R - 12	1
02.18.10.0157	Inserto de prueba tamaño 8R - 14	1
02.18.10.0158	Inserto de prueba tamaño 1L - 8	1
02.18.10.0159	Inserto de prueba tamaño 1L - 9	1
02.18.10.0160	Inserto de prueba tamaño 1L - 10	1
02.18.10.0161	Inserto de prueba tamaño 1L - 11	1
02.18.10.0162	Inserto de prueba tamaño 1L - 12	1
02.18.10.0163	Inserto de prueba tamaño 1L - 14	1
02.18.10.0164	Inserto de prueba tamaño 2L - 8	1
02.18.10.0165	Inserto de prueba tamaño 2L - 9	1
02.18.10.0166	Inserto de prueba tamaño 2L - 10	1
02.18.10.0167	Inserto de prueba tamaño 2L - 11	1
02.18.10.0168	Inserto de prueba tamaño 2L - 12	1
02.18.10.0169	Inserto de prueba tamaño 2L - 14	1
02.18.10.0170	Inserto de prueba tamaño 3L - 8	1
02.18.10.0171	Inserto de prueba tamaño 3L - 9	1
02.18.10.0172	Inserto de prueba tamaño 3L - 10	1
02.18.10.0173	Inserto de prueba tamaño 3L - 11	1
02.18.10.0174	Inserto de prueba tamaño 3L - 12	1
02.18.10.0175	Inserto de prueba tamaño 3L - 14	1
02.18.10.0176	Inserto de prueba tamaño 4L - 8	1
02.18.10.0177	Inserto de prueba tamaño 4L - 9	1
02.18.10.0178	Inserto de prueba tamaño 4L - 10	1
02.18.10.0179	Inserto de prueba tamaño 4L - 11	1
02.18.10.0180	Inserto de prueba tamaño 4L - 12	1
02.18.10.0181	Inserto de prueba tamaño 4L - 14	1
02.18.10.0182	Inserto de prueba tamaño 5L - 8	1
02.18.10.0183	Inserto de prueba tamaño 5L - 9	1
02.18.10.0184	Inserto de prueba tamaño 5L - 10	1
02.18.10.0185	Inserto de prueba tamaño 5L - 11	1
02.18.10.0186	Inserto de prueba tamaño 5L - 12	1
02.18.10.0187	Inserto de prueba tamaño 5L - 14	1
02.18.10.0188	Inserto de prueba tamaño 6L - 8	1
02.18.10.0189	Inserto de prueba tamaño 6L - 9	1
02.18.10.0190	Inserto de prueba tamaño 6L - 10	1
02.18.10.0191	Inserto de prueba tamaño 6L - 11	1
02.18.10.0192	Inserto de prueba tamaño 6L - 12	1
02.18.10.0193	Inserto de prueba tamaño 6L - 14	1
02.18.10.0194	Inserto de prueba tamaño 7L - 8	1
02.18.10.0195	Inserto de prueba tamaño 7L - 9	1

Medacta International

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
02.18.10.0196	Inserto de prueba tamaño 7L - 10	1
02.18.10.0197	Inserto de prueba tamaño 7L - 11	1
02.18.10.0198	Inserto de prueba tamaño 7L - 12	1
02.18.10.0199	Inserto de prueba tamaño 7L - 14	1
02.18.10.0200	Inserto de prueba tamaño 8L - 8	1
02.18.10.0201	Inserto de prueba tamaño 8L - 9	1
02.18.10.0202	Inserto de prueba tamaño 8L - 10	1
02.18.10.0203	Inserto de prueba tamaño 8L - 11	1
02.18.10.0204	Inserto de prueba tamaño 8L - 12	1
02.18.10.0205	Inserto de prueba tamaño 8L - 14	1
02.18.10.0230	Componente MOTO Medial - Plantilla 100%	1
02.18.10.0231	Componente MOTO Medial - Plantilla 110%	por encargo
02.18.10.0232	Componente MOTO Medial - Plantilla 115%	por encargo
02.18.10.8003	Rodilla parcial MOTO Medial - Bandeja de insertos de prueba	1
02.18.10.0599	Inserto de prueba tamaño 1R - 7 mm	por encargo
02.18.10.0600	Inserto de prueba tamaño 1L - 7 mm	por encargo
02.18.10.0601	Inserto de prueba tamaño 2R - 7 mm	por encargo
02.18.10.0602	Inserto de prueba tamaño 2L - 7 mm	por encargo
02.18.10.0603	Inserto de prueba tamaño 3R - 7 mm	por encargo
02.18.10.0604	Inserto de prueba tamaño 3L - 7 mm	por encargo
02.18.10.0605	Inserto de prueba tamaño 4R - 7 mm	por encargo
02.18.10.0606	Inserto de prueba tamaño 4L - 7 mm	por encargo
02.18.10.0607	Inserto de prueba tamaño 5R - 7 mm	por encargo
02.18.10.0608	Inserto de prueba tamaño 5L - 7 mm	por encargo
02.18.10.0609	Inserto de prueba tamaño 6R - 7 mm	por encargo
02.18.10.0610	Inserto de prueba tamaño 6L - 7 mm	por encargo
02.18.10.0611	Inserto de prueba tamaño 7R - 7 mm	por encargo
02.18.10.0612	Inserto de prueba tamaño 7L - 7 mm	por encargo
02.18.10.0613	Inserto de prueba tamaño 8R - 7 mm	por encargo
02.18.10.0614	Inserto de prueba tamaño 8L - 7 mm	por encargo

Medacta International

NOTAS

Medacta International

Los números de referencia pueden estar sujetos a cambios.

NOTAS SOBRE LA ESTERILIZACIÓN

El instrumental no es estéril en el momento del suministro. Los instrumentos deben limpiarse antes del uso y esterilizarse en un autoclave, según la normativa nacional correspondiente, las directivas de la UE (si procede) y las instrucciones de uso del fabricante del autoclave.

Para instrucciones detalladas, consulte las recomendaciones del fabricante para la limpieza, descontaminación y esterilización de los dispositivos ortopédicos, o póngase en contacto con su representante local.

Medacta International

Medacta International

DISTRIBUIDO POR

CHACO IMPLANTES
al servicio de la salud

CHACO IMPLANTES

Corrientes 781 · Resistencia, Chaco (3500) · Argentina

Tel: 0362-4571854

chacoimplantes@gmail.com

Instagram: @chacoimplanteok

MOTO® Medial · Técnica Quirúrgica

Documento de referencia: 99.38MM.32-s200 · rev. 00 · Última actualización: noviembre de 2022

Técnica quirúrgica MOTO® Medial — Fabricante: **Medacta International SA** — Distribuido por **CHACO IMPLANTES**